

Guía Preanestésica para Pacientes

Material educativo interactivo y oficial para la preparación preoperatoria del paciente quirúrgico.

Dr. Jhonatan Guevara Marín

Médico Anestesiólogo · CMP 074566 · RNE 051391

1. La Consulta Preanestésica y tu Seguridad

La consulta preanestésica es una evaluación obligatoria y fundamental de acuerdo a la **Resolución Ministerial N° 660-2022/MINSA** en el Perú y los estándares de la **Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA)**. Su principal objetivo es evaluar tu estado físico, identificar factores de riesgo y planificar el plan anestésico más seguro para tu cirugía.

El Rol del Anestesiólogo

Contrario al mito popular, el anestesiólogo no solo "te duerme". Somos los médicos especialistas encargados de monitorizar y mantener estables tus funciones vitales (corazón, pulmones, presión arterial y cerebro) durante todo el procedimiento quirúrgico y asegurar que despiertes con el menor dolor posible.

Clasificación del Estado Físico (ASA)

Para catalogar tu estado general de salud antes de la cirugía, los anestesiólogos utilizamos la clasificación del estado físico de la ASA. Esto nos ayuda a anticipar necesidades y optimizar tu cuidado:

Clasificación	Descripción Clínica	Ejemplos Comunes
ASA I	Paciente sano, no fumador, con mínimo o nulo consumo de alcohol.	Sin enfermedades crónicas ni cirugías recientes.
ASA II	Paciente con enfermedad sistémica leve controlada, sin limitaciones funcionales.	Hipertensión o diabetes controlada, fumador activo, sobrepeso leve.
ASA III	Paciente con enfermedad sistémica grave, no incapacitante, con impacto funcional.	Diabetes no controlada, antecedente de infarto (>3 meses), EPOC, obesidad severa.
ASA IV	Paciente con enfermedad sistémica grave que representa una amenaza constante para la vida.	Infarto reciente (<3 meses), angina inestable, falla renal sin diálisis estable.

Nota sobre el Riesgo Quirúrgico Cardiovascular

En el Perú, los establecimientos de salud solicitan además el "Riesgo Quirúrgico" elaborado por cardiología o medicina interna. Esta evaluación complementa pero **no reemplaza** la evaluación de tu anestesiólogo.

2. El Ayuno Preoperatorio: La Regla del 2-4-6-8

El ayuno no es un capricho médico, es una **medida de seguridad vital** respaldada por las guías clínicas mundiales de la ASA y la ESAIC. Cuando pierdes la conciencia por la anestesia, tus reflejos de protección se apagan. Si tienes comida en el estómago, esta puede regresar al esófago e ingresar a los pulmones, causando una complicación grave llamada **broncoaspiración**.

Tiempos de Ayuno Clínico Oficial (Pauta ASA 2023)

Debes cumplir estrictamente con los siguientes tiempos mínimos de ayuno antes de tu hora programada de ingreso a sala:

Tipo de Alimento	Ayuno Mínimo	Ejemplos y Detalles
Líquidos Claros	2 HORAS	Agua sola, té o café negro (sin leche), bebidas hidratantes sin pulpa ni grasas.
Leche Materna	4 HORAS	Aplica exclusivamente para lactantes que consumen leche materna directa.
Fórmula Lactante / Leche	6 HORAS	Leche de fórmula infantil, leche de vaca u otros mamíferos, y jugos con pulpa.
Comida Ligera	6 HORAS	Una tostada con mermelada (sin mantequilla), té con galletas de agua.
Comida Completa o Copiosa	8 HORAS	Cualquier comida que incluya frituras, grasas, carnes, lácteos enteros o quesos.

¡Atención! ¿Qué NO es un líquido claro?

Los caldos de sopa, la leche (incluso descremada), los yogures, los jugos con pulpa (como mango o naranja licuada) y las bebidas alcohólicas **no son líquidos claros** y requieren un mínimo de 6 a 8 horas de ayuno.

¿Por qué se recomiendan líquidos claros hasta 2 horas antes?

Los líquidos claros se absorben muy rápido y estimulan el vaciamiento gástrico, disminuyendo la acidez del estómago. Esto evita deshidrataciones severas y dolores de cabeza preoperatorios innecesarios. Sin embargo, recuerda detener todo consumo exactamente 2 horas antes.

3. Medicamentos: ¿Cuáles tomar y cuáles suspender?

Muchos medicamentos interactúan con los anestésicos o alteran la coagulación. Es crítico clasificar tu medicación habitual según los protocolos de seguridad clínica:

1. Medicamentos que SÍ deben tomarse (con un mínimo sorbo de agua)

Por lo general, no debes suspender tu medicación para la presión o el corazón que pertenezca a las siguientes clases, ya que suspenderlas abruptamente puede provocar crisis hipertensivas o arritmias en sala:

- **Beta-bloqueadores:** Atenolol, Metoprolol, Carvedilol, Bisoprolol.
- **Calcioantagonistas:** Amlodipino, Nifedipino, Verapamilo.
- **Medicamentos de la tiroides:** Levotiroxina (debe tomarse a primera hora como es habitual).

2. Medicamentos que obligatoriamente DEBEN SUSPENDERSE

Medicamento	Cuándo Suspender	Razón Clínica / Riesgo
IECA / ARA II (Enalapril, Losartán, Valsartán)	24 HORAS ANTES	Riesgo de hipotensión severa y refractaria (presión muy baja difícil de revertir) durante la inducción de la anestesia.
Metformina	24 A 48 HORAS	Riesgo de desarrollar acidosis láctica (complicación grave en la sangre), especialmente si se emplean sustancias de contraste.
Inhibidores SGLT2 (Dapagliflozina, Empagliflozina)	3 DÍAS ANTES	Riesgo de cetoacidosis diabética euglicémica (una alteración metabólica grave con niveles de azúcar aparentemente normales).
Anticoagulantes (Warfarina)	5 DÍAS ANTES	Riesgo de sangrado quirúrgico severo. Requiere control de INR (<1.5) y, según el caso, terapia puente con Enoxaparina.
Antiagregantes (Clopidogrel, Prasugrel)	5 A 7 DÍAS	Evita hemorragias incontrolables en el sitio quirúrgico o hematomas en anestesia epidural.
Suplementos y Vitaminas (Ginkgo Biloba, Ajo, Ginseng)	7 DÍAS ANTES	Alteran la coagulación normal e incrementan el tiempo de sangrado. La valeriana prolonga el sueño anestésico.

Importante: Regla de Oro sobre Diabetes

Si usas **insulina**, la mañana de la cirugía debes ****suspender la dosis de acción rápida**** porque estarás en ayuno, y reducir la dosis de insulina basal según indicación médica para evitar hipoglucemias graves en el quirófano.

4. Tipos de Anestesia y la Lista de Seguridad OMS

El plan anestésico se diseña de manera personalizada según tus antecedentes y el tipo de procedimiento:



Anestesia General

Inconsciencia total y ausencia de dolor en todo el cuerpo. Requiere control de la respiración con un ventilador mecánico y dispositivos avanzados de vía aérea. Ideal para cirugías mayores de tórax, abdomen alto o neurocirugía.



Anestesia Regional

Se bloquea el dolor en una región del cuerpo (ej. de la cintura hacia abajo usando anestesia raquídea o epidural). Permaneces despierto o con sedación leve, sintiéndote relajado y cómodo sin percibir dolor.

Detrás de Escena: La Lista de Chequeo de Cirugía Segura (OMS)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el MINSA establecen una lista de verificación obligatoria en quirófano dividida en tres etapas críticas, en las cuales participas activamente:

☐ 1. Entrada (Sign In) — Antes de la inducción anestésica

El anestesiólogo y enfermería confirman verbalmente contigo: tu identidad, el sitio quirúrgico exacto, el procedimiento a realizar, tu consentimiento firmado, si tienes alergias y el tiempo de ayuno cumplido.

☐ 2. Pausa Quirúrgica (Time Out) — Antes de la incisión en piel

Todo el equipo detiene sus labores para confirmar en voz alta el nombre del paciente, el procedimiento exacto, si se administró el antibiótico preventivo en los últimos 60 minutos y los pasos críticos planeados.

☐ 3. Salida (Sign Out) — Antes de que el paciente salga del quirófano

Se realiza el conteo exacto de gasas, agujas e instrumental para asegurar que nada quede dentro del paciente, se rotulan las muestras biológicas con tus datos completos y se define el plan analgésico de recuperación.

5. Preguntas Clave y Errores a Evitar

Preparar tus dudas con anticipación reduce la ansiedad. A continuación, te sugerimos preguntas clave y los errores más comunes que debes evitar para asegurar un procedimiento exitoso.

Preguntas Recomendadas para tu Consulta

Usa esta lista para guiar la conversación con tu anestesiólogo antes de ingresar al quirófano:

1. **¿Qué tipo de anestesia es la más segura para mí** considerando mis antecedentes médicos?
2. **¿Cuáles son los riesgos particulares de la anestesia en mi caso** y cómo se previenen?
3. **¿Qué medicamentos debo suspender y cuáles tomar** la mañana de la cirugía?
4. **¿Cómo se controlará mi dolor al despertar** y en los días posteriores a la cirugía?
5. **¿Cuáles son los signos de alarma** que debo observar durante mi recuperación en casa?

Errores Críticos que Debes Evitar obligatoriamente

Cometer estos errores puede poner en riesgo tu vida o causar la cancelación inmediata de tu cirugía:

✗ Ocultar Antecedentes o Hábitos

No declarar el consumo de alcohol, tabaco, vapeo o medicamentos naturales altera el cálculo de dosis y puede causar arritmias o despertar superficial en sala.

✗ Desobedecer las Horas de Ayuno

Comer caramelos, chicles, tomar café con leche o agua poco antes de la cirugía incrementa el riesgo de broncoaspiración a nivel pulmonar.

✗ Omitir Síntomas de Infección

Ingresar a sala con tos, congestión nasal, fiebre o malestar estomacal eleva el riesgo de espasmo bronquial o complicaciones respiratorias bajo anestesia.

✗ Automedicarse

Tomar aspirinas o antiinflamatorios (Ibuprofeno/Naproxeno) por dolor o nervios antes de la cirugía incrementa severamente el riesgo de sangrado.

Recuerda: Tu seguridad es un trabajo en equipo

Proporcionar información verídica, respetar el ayuno y seguir las indicaciones médicas de tu anestesiólogo son las herramientas más poderosas para garantizar una cirugía sin complicaciones. ¡Tu salud es lo primero!

